

ASTHME DE L'ADULTE

(évaluation:obj7)

Pr Saoussen cheikh m'hamed

Service de Pneumologie et d'Allergologie

Hôpital Universitaire F. Bourguiba Monastir

Résidanat 2025

L'asthme est une maladie caractérisée par :

- A- des sécrétions bronchiques chroniques
- B- une inflammation bronchique
- C- une HRB
- D- un TVO irréversible
- E- des accès de dyspnée aigue



les risques de développer un asthme sont plus importants en cas de :

- A- antécédents familiaux d'allergie respiratoire
- B- pneumopathies à répétition
- C- tabagisme
- D- déficit en alpha anti trypsine
- E- antécédents personnels d'allergie médicamenteuse



les signes cliniques en faveur d'une crise d'asthme sont :

- A- une hypertension artérielle
- B- une dyspnée expiratoire
- C- une oppression thoracique
- D- une douleur thoracique
- E- une tachycardie

**chez l'asthmatique jeune au cours d'une
crise d'asthme modérée, on rencontre
habituellement :**

A- une ↓ de la CPT

B- une ↓ du VEMS

C- une hypercapnie

D- une réversibilité du TVO

E- une augmentation des résistances des voies
aériennes

Les traits suivants caractérisent la maladie asthmatique :

A- hétérogénéité

B- origine allergique constante

C- dyspnée sifflante

D- variabilité des symptômes

E- bronchorrhée chronique



Le(s) examen(s) complémentaire(s) nécessaire(s) pour confirmer un diagnostic d'asthme est (sont):

- A- le dosage des IgE spécifiques
- B- les tests cutanés allergologiques
- C- le test de provocation bronchique non spécifique
- D- la radiographie du thorax
- E- la gazométrie sanguine

les facteurs suivants sont associés à un **risque élevé de mortalité** dans l'asthme :

A-antécédents d'asthme aigu grave

B- allergie aux acariens

C- arrêt brutal d'une corticothérapie

D- traitement par LABA

E- Rhinite allergique



les signes de gravité d'une crise d'asthme sont :

A- une toux sèche

B- une hypercapnie

C- des râles sibilants

D- une distension thoracique à la radio thorax

E- des signes de lutte respiratoire



les éléments suivants plaident en faveur de l'origine allergique de l'asthme :

- A- les antécédents personnels d'atopie
- B- un trouble ventilatoire obstructif réversible
- C- la survenue concomitante d'un eczéma
- D- la présence d'une hyperréactivité bronchique non spécifique
- E- une atopie familiale



dans l'asthme allergique les examens complémentaires suivants permettent d'identifier l'allergène responsable :

A- recherche d'éosinophiles dans l'expectoration

B- dosage des IgE spécifiques

C- tests cutanés allergologiques

D- test de provocation spécifique

E- dosage des IgE totales



le syndrome de Churg-Strauss associe :

- A- un cancer bronchique et une polyarthrite rhumatoïde
- B- une tuberculose et une silicose
- C- un asthme et une polyarthrite rhumatoïde
- D- un asthme et une vascularite
- E- une tuberculose et une polyarthrite rhumatoïde



l'auscultation met en évidence des râles sibilants dans les affections suivantes :

A- une crise d'asthme

B- une exacerbation de BPCO

C- une pleurésie

D- une pneumonie

E- un pneumothorax



Devant une crise d'asthme modérée on peut prescrire du :

- A- théophylline par voie orale
- B- salbutamol en nébulisation (Aérol)
- C- Singulair (montelukast)
- D- corticothérapie orale
- E- terbutaline inhalée (Bricanyl)



les perturbations suivantes caractérisent la maladie asthmatique :

- A- bronchospasme
- B- inflammation de la muqueuse
- C- fibrose péri bronchiolaire
- D- hypersécrétion bronchique
- E- destruction alvéolaire



les médicaments suivants peuvent engendrer une tachycardie :

- A- β_2 agonistes courte durée d'action
- B- β_2 adrénergiques longue durée d'action
- C- les anticholinergiques
- D- les corticoïdes inhalées
- E- les anti leucotriènes



les effets secondaires des anticholinergiques sont :

A- palpitation

B- dysphonie

C- candidose buccale

D- hyper-sécrétion bronchique

E- sécheresse de la bouche



**en cas de crise d'asthme,
le médicament le plus rapide à agir
est le :**

A- Aérol[®] spray

B- Bronchophylline[®]

C- Atrovent[®]

D- antileucotrienes

E- Corticoïdes en IV



la prescription la plus adaptée à une crise d'asthme comporte :

- A- les β_2 adrénergiques en aérosol doseur
- B- l'adrénaline en inhalation
- C- la béclo méthasone
- D- une inhalation de fluticasone
- E- une injection I.V. de théophylline



On peut prescrire en cas de crise d'asthme :

A- Les mucolytiques

B- les beta2 adrénergiques inhalés

C- les corticoïdes par voie générale

D- Les antitussifs

E- l'oxygénothérapie

chez l'asthmatique, les corticoïdes inhalés en aérosol-doseur :

A- sont bronchodilatateurs

B- sont anti inflammatoires

C- sont administrés en traitement de fond

D- sont susceptibles d'engendrer des complications locales

E- sont prescrits uniquement en cas

d'asthme aigue grave



**chez un asthmatique, un AAG
peut être déclenché par une :**

A- prise d'aspirine

B- infection bronchopulmonaire

C- oxygénothérapie à fort débit

D- prise de corticoïdes

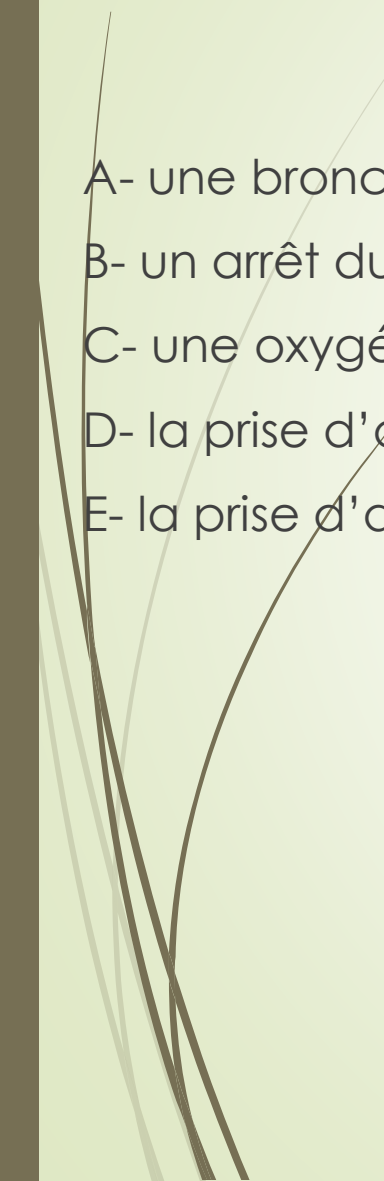
E- prise de β bloquants

**chez un patient asthmatique
sévère, la survenue d'un asthme
aigu grave peut être dû à :**

- A- un arrêt d'une corticothérapie inhalée
- B- un usage excessif de β_2 adrénergiques
inhalés
- C- un accident d'immunothérapie allergénique
- D- une prise de sédatifs
- E- des facteurs psychologiques



un AAG peut être déclenché par :

- A- une bronchite virale
 - B- un arrêt du traitement
 - C- une oxygénothérapie à fort débit
 - D- la prise d'anticholinergiques
 - E- la prise d'anti tussifs
- 



les éléments cliniques suivants sont en faveur de la sévérité de la crise d'asthme :

A- une fréquence cardiaque : 128 /mn

B- une fréquence respiratoire : 34 cycles/mn

C-une distension thoracique

D- un DEP : 20% de la valeur théorique

E- des sibilants audibles à l'auscultation

une crise d'asthme sévère est caractérisée par :

- A- la présence d'une distension thoracique à la radio
- B- une chute du VEMS
- C- une hypoxémie artérielle au repos
- D- une baisse des résistances des voies aériennes
- E- un effondrement du débit de pointe

cas clinique 1

Un jeune de 30 ans, asthmatique dès le jeune âge consulte les urgences pour une crise d'asthme évoluant depuis quelques heures.

A l'examen : conscient, FR à 37 c/mn, FC : 121b/mn, T° 38,3°C, TA : 12/8, hyper sonorité à la percussion, râles sibilants à l'auscultation. Le débit expiratoire de pointe (DEP) est à 120 L/mn (Normal : 600 L/mn), GDS: PaO₂ : 62 mmHg, PCO₂ : 46mm Hg, pH : 7,30



les éléments en faveur de la sévérité de la crise d'asthme sont :

A- la fréquence respiratoire 37c/mn

B- l'hyper sonorité à la percussion

C- la température à 38,3°C

D- le débit de pointe à 120 L/mn

E- Un PH a 7,30



le traitement de première intention dans ce cas comporte :

- A- les β_2 adrénergiques en nébulisation
- B- des antibiotiques par voie générale
- C -L'oxygénothérapie
- D- la corticothérapie par voie générale
- E- la ventilation mécanique invasive

le patient est revu 3 mois plus tard, il présente de rares épisodes d'oppression thoracique, la spirométrie à l'état de base montre : VEMS : 2,10 L (68% de la théorique), rapport VEMS/CVF : 65%.

Le traitement de fond de l'asthme dans ce cas comporte une association de :

- A-anti leucotrienes
- B- $\beta 2$ sympathomimétiques de longue action
- C- corticothérapie inhalée
- D- corticothérapie continue per os
- E- anticholinergiques en continu



une exacerbation aiguë d'asthme peut être déclenchée par :

- A- un β bloquant
- B- un β_2 adrénergique
- C- des acariens
- D- une bronchite virale
- E- une corticothérapie orale

Cas clinique 2

Femme âgée de 36 ans, asthmatique depuis 10 ans, consulte pour dyspnée aiguë

A l'examen physique, T° : 37°C, Fr : 32 cycles/mn, Fc : 122b/mn, TA : 120/50 mm de hg, SaO₂ (AA): 89%, auscultation pulmonaire : des râles sibilants bilatéraux, peak flow 150 L/mn

GDS : pH : 7,48, PaO₂ : 58 mmHg, PaCO₂ : 28 mmhg, HCO₃⁻ : 20 mmol/l, SaO₂ : 89%



Quels sont parmi ces données les éléments orientant vers la gravité de la crise ?

- A- Fréquence respiratoire : 32 cycles/mn,
- B- l'ancienneté de l'asthme (10 ans)
- C- des râles sibilants bilatéraux
- D- Fréquence cardiaque : 122b/mn
- E- peak flow 150 L/mn



La Prise en charge comprend :

- A- une hospitalisation dans un service de réanimation
- B- une oxygénothérapie
- C- des nébulisations d'adrénaline
- D- des antibiotiques par voie générale
- E- des corticoïdes systémiques

quel serait votre prescription de sortie ?

A- β 2 mimétique courte durée d'action

B-Corticoïde inhalé + β longue durée d'action

C- Des nébulisations de corticoïdes à domicile

D-Corticothérapie par voie orale pendant quelques jours

E-Des anticholinergiques longue durée d'action

Au cours de la crise d'asthme de l'adulte :

- A. La dyspnée est inspiratoire
- B. L'auscultation trouve des râles sibilants
- C. Le silence auscultatoire est un signe de gravité
- D. Il existe une diminution de débit de pointe
- E. Il existe une hyper sonorité bilatérale à la percussion



Parmi les perturbations suivantes, celles qui caractérisent la maladie asthmatique sont :

- A. Inflammation bronchique
- B. Destruction alvéolaire
- C. Hyperréactivité bronchique
- D. Expectoration chronique
- E. Déficit ventilatoire obstructif constant



les mesures préventives de l'AAG peuvent être :

- A- précocité du traitement des exacerbations
- B- monitoring du débit de pointe
- C- corticothérapie inhalée adaptée
- D- vaccin anti pneumococcique
- E- éviction des allergènes

**une crise d'asthme peut être
déclenchée par :**

A - L'exercice physique

B - L'anxiété

C - L'inhalation de grains de pollen

D - La prise des beta bloquants

E - L'inhalation de Salbutamol

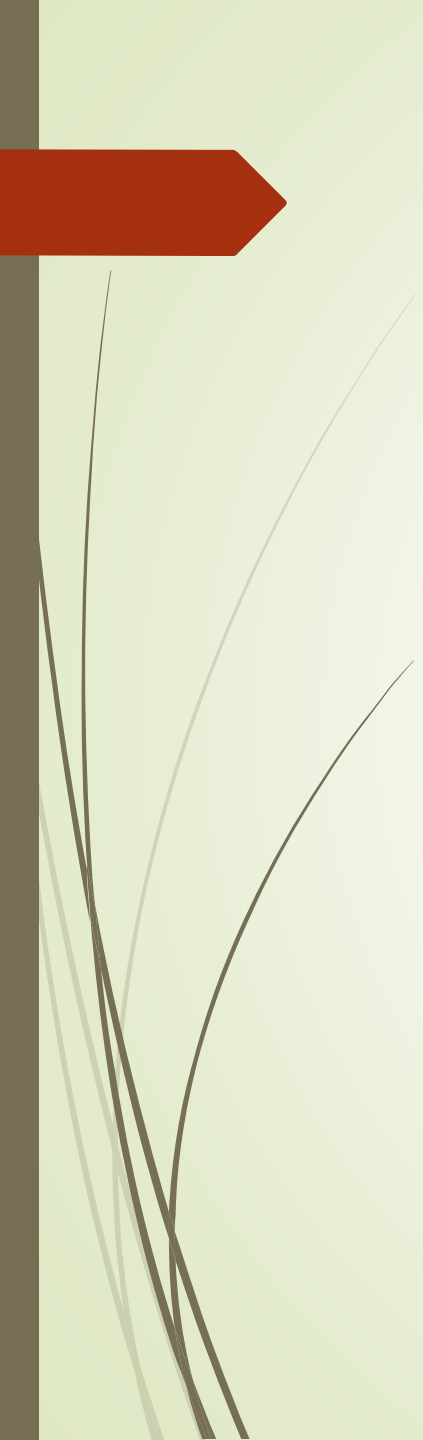
Si l'asthme est non contrôlé par un traitement de fond à base de corticothérapie inhalée faible dose, on peut :

- A. Augmenter la dose de corticothérapie inhalée
- B. Associer un LAMA
- C. Associer un LABA
- D. Arrêter la corticothérapie inhalée et donner un LABA
- E. Arrêter la corticothérapie inhalée et donner un LAMA et LABA

Cas clinique 3

Une patiente âgée de 28 ans, asthmatique depuis l'âge de 20 ans traitée régulièrement par corticothérapie inhalée et des bronchodilatateurs à la demande,

Elle rapporte une gêne respiratoire quotidienne nécessitant le recours aux bronchodilatateurs, des réveils nocturnes à raison de 2 fois par semaine et un retentissement modéré sur l'activité quotidienne, ainsi que des symptômes de reflux gastro-oesophagien,

- 
- Depuis 2 jours elle présente une aggravation rapide des symptômes nécessitant la consultation aux urgences
 - l'examen trouve : FR 24 C/mn ,FC 128b/mn, des râles sibilants audibles aux deux champs pulmonaires, tympanisme bilatérale à la percussion, DEP 120 L/mn , Saturation(AA) 88%



En faveur de mauvais contrôle de l'asthme chez cette patiente

- A. Les symptômes quotidiens
- B. L'usage fréquent des bronchodilatateurs
- C. Le réveil nocturne deux fois/ semaine
- D. Les symptômes de reflux gastro-oesophagien
- E. L'ancienneté de l'asthme

Les signes suivants sont en faveur de la **sévérité** de la crise d'asthme chez notre patiente :

- A. Râles sibilants audibles aux 2 champs pulmonaires
- B. Tympanisme bilatéral à la percussion
- C. Débit expiratoire de pointe : 120 L/mn
- D. Saturation au doigt 88%
- E. Fréquence cardiaque 128b /mn

Le traitement de cette exacerbation doit comporter :

- A. Les nébulisations de bronchodilatateurs
- B. La corticothérapie inhalée
- C. La corticothérapie en intraveineuse
- D. Une ventilation non invasive
- E. L'oxygénothérapie

parmi ces examens, quel est celui à réaliser en première intention chez un patient qui consulte pour crise d'asthme :

A-Un scanner thoracique

B- des GDS

C-Une pléthysmographie

D-Des tests cutanés allergologiques

E- La mesure du débit expiratoire de pointe



Cas clinique 4

Femme âgée de 25 ans, asthmatique depuis 2 ans sous cortis 250 , consulte aux urgences pour crise d'asthme.

A l'examen physique : T° :37°C, FR : 34cycles/mn, Fc : 122b/mn, PF=150L/mn
TA : 120/60 mm hg, SaO₂ : 87%,
auscultation pulmonaire : des râles sibilants bilatéraux.

La radiographie du thorax montre une distension thoracique



Relevez les signes en faveur de la sévérité de la crise ?

A/FR=34 cy/mn

B/PF=150L/mn

C/FC = 122b/mn

D/SaO₂:87%

E/ Une distension thoracique



Quel traitement prescrivez-vous en urgence ?

A/Oxygénothérapie

B/une VNI

C/Nébulisation des bronchodilatateurs

D/Corticothérapie systémique

E/Sulfate de magnésium



Une spirometrie a été réalisée montrant une CV F(2,3l)78% un VEMS (1,78l) 56% après test aux bronchodilatateurs le VEMS est à 2l il s'agit :

A/ d'une spirométrie normale

B/ d'un trouble ventilatoire restrictif

C/ d'un déficit ventilatoire obstructif réversible

D/ d'un trouble ventilatoire mixte

E/ d'une pléthysmographie normale



Les thérapeutiques suivantes peuvent être administrées dans le palier 4 de traitement de fond de l' asthme :

A-LABA

B- corticothérapie inhalée

C- anti IgE (omalizumab)

D- anti leucotriene

E- corticothérapie orale continue



A propos de l'asthme

:

A- la spirométrie montre toujours un TVO réversible

B- l' auscultation pulmonaire trouve toujours des râles sibilants

C – la corticothérapie inhalée associée au LABA est indiquée dans l'étape 3 du traitement de fond de l' asthme

D-Le step up et le step down dépendent du niveau de contrôle de la maladie asthmatique

E- le traitement de fond ne doit jamais comporter un LABA seul

➤ **Le step down chez un asthmatique bien contrôlé recevant une corticothérapie inhalée(CI) dose moyenne avec LABA consiste à:**

A- arrêter la CI et garder le LABA

B-arrêter le LABA et garder la CI

C-réduire la dose de CI et garder le LABA

D- réduire la dose de CI et arrêter le LABA

E-arrêter l'association CI \LABA et donner LABA
\LAMA

Cas clinique 5

Patiente âgée de 48ans ,asthmatique depuis 5ans, ayant un traitement de fond à base de corticothérapie inhalée faible dose et beta2 adrénergique CDA à la demande .

Depuis 3 mois elle présente une gêne respiratoire avec recours quotidien au salbutamol , des réveils nocturnes 1 fois par semaine ,un retentissement sur l'activité quotidienne

L'examen physique montre une FR à 20cy/mn FC à 85btt /mn, un DEP à 450L/mn ,des sibilants à l' auscultation pulmonaire

Les éléments qui sont en faveur d'un mauvais contrôle de l'asthme sont :

A- gêne respiratoire quotidien

B- usage quotidien du salbutamol

C- réveils nocturne 1 fois / semaine

D- retentissement sur l'activité
quotidienne

E- DEP 450L /mn



S'agissant d' un asthme non contrôlé vous décidez alors d'associer au traitement:

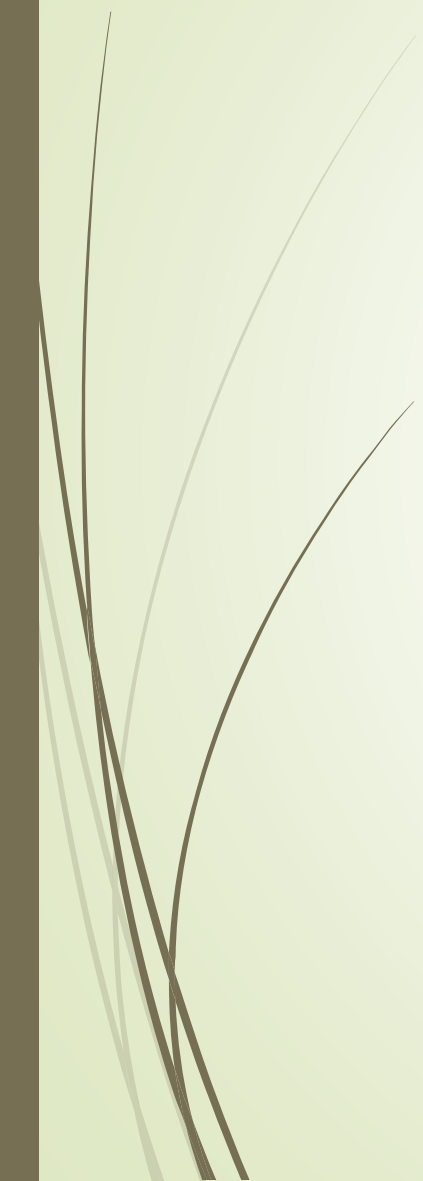
A-un LABA

B- un LAMA

C-un LABA et un LAMA

D- une corticothérapie orale continue

E- un Anti IgE



Trois mois après la patiente se présente aux urgences pour aggravation de sa dyspnée ,
l' examen trouve une patiente consciente avec cyanose modérée des extrémités ,la FR 32 cy/mn, FC 125 bat/mn ,SAO2(AA) 87% ,GDS (AA) PAO2: 50 mm de Hg ,PACO2 : 33 mm hg, PH 7,49 ,HCO3-:18 mmol/L



Votre conduite thérapeutique initiale dans ce cas est :

- A- oxygénothérapie
- B- corticothérapie intraveineuse
- C- nébulisation des bronchodilatateurs
- D- nébulisation d'adrénaline
- E- ventilation mécanique